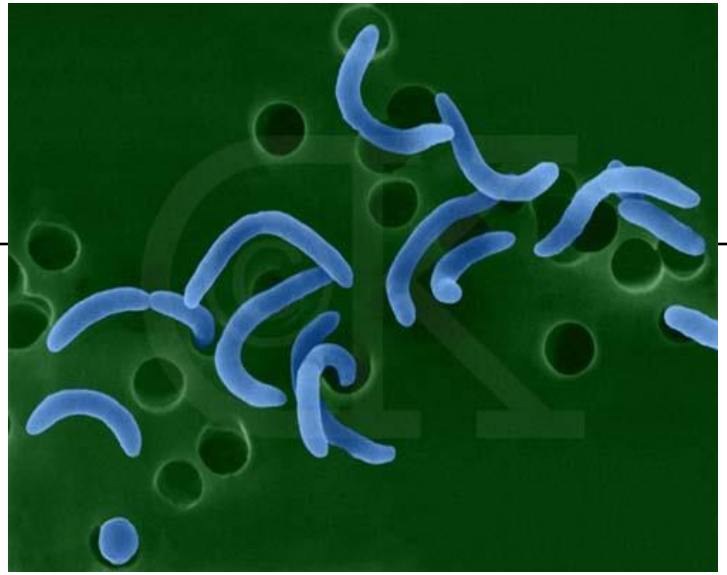
DỊCH TỄ HỌC BỆNH TẢ



MỤC TIÊU

1. Trình bày được tác nhân gây bệnh tả
2. Nêu được đặc điểm dịch tễ của bệnh tả
3. Mô tả được quá trình dịch của bệnh tả
4. Trình bày được các biện pháp phòng chống dịch đối với bệnh tả

ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH

- Là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính
- Rối loạn tiêu hóa
- TC: ỉa lỏng, nôn, mất nước, trụy mạch, không đau bụng, không sốt.
- Biểu hiện đa dạng:
  - Thể thông thường
  - Thể tả khô
  - Thể xuất huyết
- Được xếp vào bệnh “tối nguy hiểm”

TÁC NHÂN GÂY BỆNH

TÁC NHÂN GÂY BỆNH

- Phẩy khuẩn tả (Vibrio cholerae), họ Vibrionaceae
- Hình cong như dấu phẩy
- Không bắt màu gram
- Không sinh nha bào
- Di động được nhờ có lông.
- Có 140 nhóm huyết thanh: chỉ có nhóm huyết thanh O là gây được bệnh tả;
- Được chia thành V. cholerae-O1 và V.cholerae non-O1.

TÁC NHÂN GÂY BỆNH

- V. cholerae O1 có 2 typ sinh học (biotyp) là V. cholerae classica và V. cholerae eltor.
- Dựa vào đặc điểm các quyết định KN A, B, C của kháng nguyên thân O, Mỗi typ sinh học lại được chia thành 3 typ huyết thanh (serotyp) sau:
  - Serotyp Ogawa (có KN A, B).
  - Serotyp Inaba (có KN A, C).
  - Serotyp Hikojima (có cả 3KN A, B, C).

TÁC NHÂN GÂY BỆNH

- V. cholerae-non O1 nhóm huyết thanh O139 là thủ phạm gây dịch tả ở Ấn Độ và một số nước châu Á từ năm 1992 đến nay.
- Gây bệnh nhờ nội độc tố
- Phát triển tốt trong môi trường nghèo dinh dưỡng, pH kiềm (pH >7).

TÁC NHÂN GÂY BỆNH

- Ở môi trường thích hợp nhất là trong nhiệt độ 25-37 độ C, VK tả sống rất lâu:
  - Đất: 60 ngày
  - Nước: 20 ngày
  - Phân: 150 ngày
  - Bề mặt thân thể: 30 ngày
  - Sữa: 6-10 ngày
  - Rau quả: 7-8 ngày
- Dễ bị diệt bởi nhiệt độ (80°C/5 phút), bởi hoá chất thông thường và môi trường axit

TÁC NHÂN GÂY BỆNH

- Phẩy khuẩn tả có thể tồn tại và nhân lên ở động vật giáp xác (chủ yếu dưới biển) khi điều kiện môi trường không phù hợp, chúng có thể chuyển sang trạng thái ngủ và có thể tồn tại hàng tháng, hàng năm.
- Ở trạng thái này vi khuẩn có thể kháng lại chlorid và không thể nuôi cấy.

DỊCH TỄ HỌC BỆNH TẢ

- Năm 1817 bệnh tả
- Năm 1854 tìm thấy VK tả
- Năm 1849: Phương thức lây truyền bệnh tả
- Thế giới đã trải qua 7 vụ đại dịch
- Từ 1817 đến 1923 đã có 6 vụ, đều bắt đầu từ Ấn Độ và đều do V. cholerae O1 typ sinh học classic gây ra.

DỊCH TỄ HỌC BỆNH TẢ

- Vụ đại dịch thứ 7 do V.cholerae typ sinh học eltor, có nguồn gốc từ đảo Celebes của Indonesia năm 1961. Kéo dài nhất và có phạm vi rộng hơn 6 vụ trước, đến nay còn nhiều nước thông báo những đợt bùng phát dịch tả do căn nguyên này gây ra.
- Năm 1992 V.cholerae non – O1 nhóm huyết thanh O139 được xác đinh là thủ phạm gây dịch tả ở Madras và vịnh Bengal Ấn Độ lan sang một số nước châu Á (Pakistan, Nepal, Mianma, Thái lan, miền tây Trung Quốc, Malaysia...)

DỊCH TỄ HỌC BỆNH TẢ

- Bệnh tả ảnh hưởng khoảng 3-5 triệu người trên khắp thế giới
- Gây ra 58.000–130.000 ca tử vong mỗi năm tính đến năm 2010
- Vào đầu thập niên 1980, tỉ lệ tử vong được tính là có hơn 3 triệu mỗi năm
- Rất khó để tính chính xác số ca bệnh, vì nhiều trường hợp không được báo cáo do lo ngại rằng nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động du lịch của quốc gia.

DỊCH TỄ HỌC BỆNH TẢ

- Chủ yếu xuất hiện ở các nước đang phát triển, những vùng trình độ KT-XH-VS thấp kém
- Có tính chất mùa
- Bệnh tả vẫn còn tồn tại quy mô dịch ở nhiều khu vực trên thế giới.

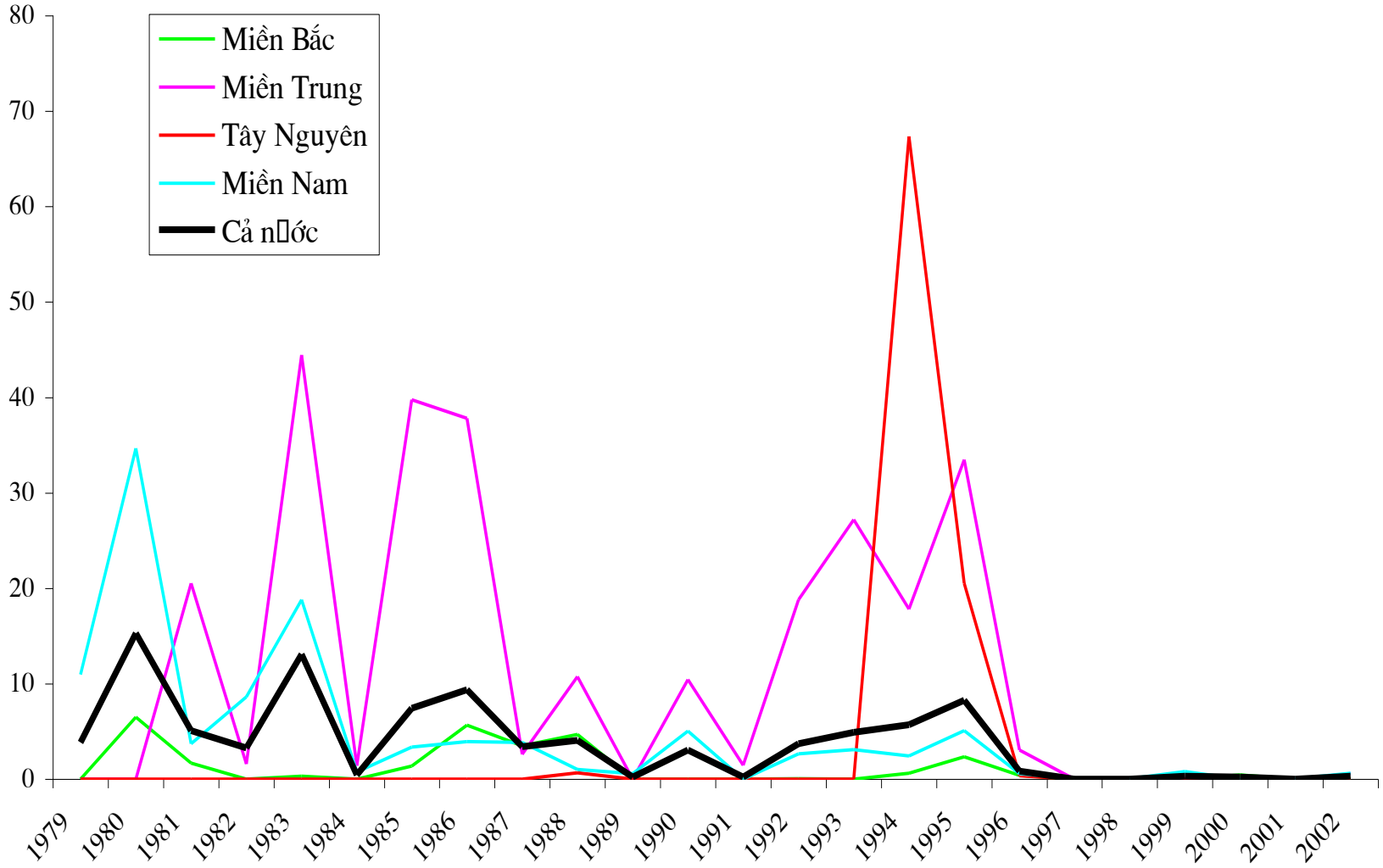
Bệnh tả được ghi nhận đầu tiên ở Việt Nam vào năm 1791 ở Sơn Tây (Hà Sơn Bình cũ). Năm 1820 và 1821 Hà Nội có bệnh tả. Còn ở Nam Bộ năm 1930 tại Gia Định xuất hiện bệnh tả. Ở Trung Bộ năm 1840 tại Huế có bệnh tả. Từ đó các năm về sau đều có dịch.

- Năm 1885, một vụ dịch tả đã xảy ra trong một đơn vị quân đội Pháp, tỷ lệ tử vong tới 50%. Từ năm 1910 - 1938, hàng năm số bệnh nhân mắc tả được thông báo dao động từ 5.000 - 30.000 người. Năm 1937 - 1938, dịch tả từ Hồng Kông theo đường biển xâm nhập vào các tỉnh phía Bắc là Hải Phòng, Quảng Ninh (Móng Cái). Từ đó dịch lan theo đường sắt và đường bộ tới nhiều tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, số mắc lên tới 20.687 người trong đó số chết là 14.992 người (tỷ lệ tử vong 70%).

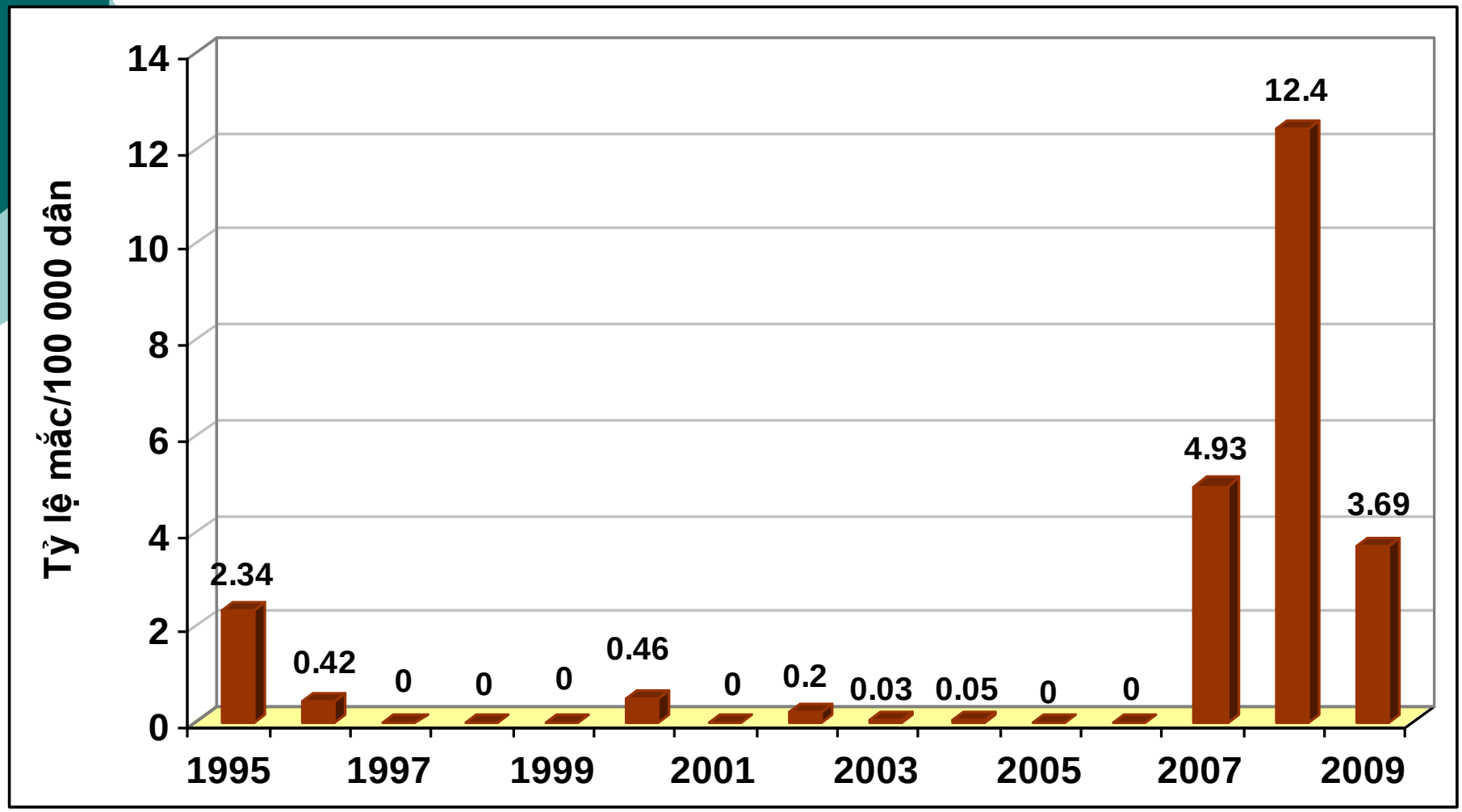
- Vụ dịch tả lớn nhất ở Việt Nam vào năm 1964 là mở đầu cho sự xâm nhập đại dịch tả lần thứ 7 vào miền Nam Việt Nam do *Vibrio cholerae Eltor* với số người mắc lên tới 20.009 người và 821 trường hợp tử vong. Sau đó trong nhiều năm ở miền Trung và miền Nam bệnh tả xảy ra dưới dạng lưu hành, hàng năm có hàng trăm bệnh nhân mắc tả được thông báo.

Sau năm 1975 do việc thông thương đi lại giữa hai miền Nam Bắc, bệnh tả đã lây lan ra miền Bắc và gây ra những vụ dịch tả rải rác ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng khẳng định là bệnh tả lưu hành ở miền Bắc. Năm 1994, dịch xảy ra ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam với 4.123 trường hợp mắc bệnh. Năm 1995, 29 tỉnh thành phố báo cáo có bệnh nhân tả với 6.088 trường hợp

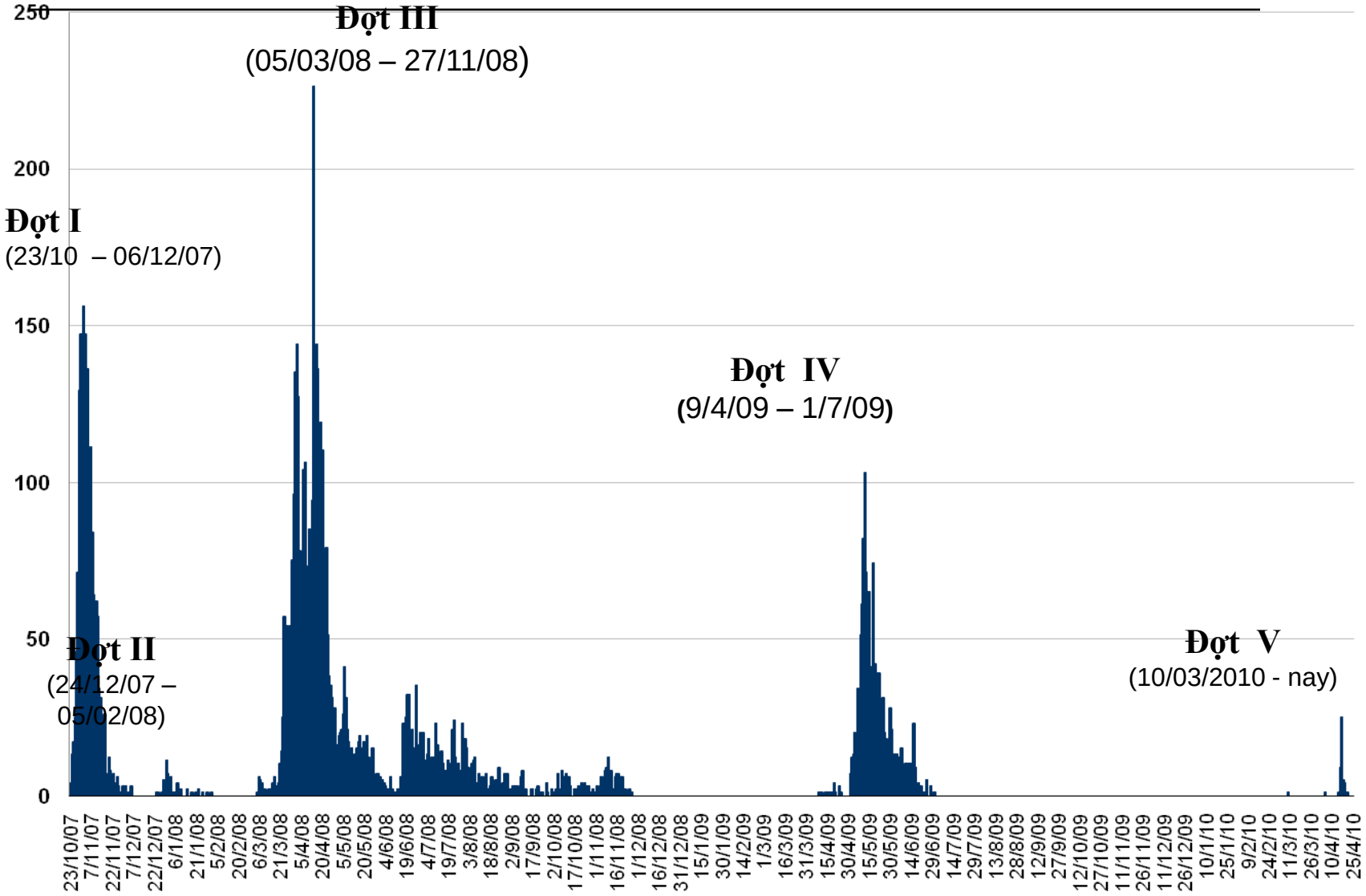
TỶ LỆ MẮC/100.000 DO BỆNH TẢ PHÂN THEO KHU VỰC TẠI VIỆT NAM 1979-2002



TÌNH HÌNH BỆNHTẢ
KHU VỰC MIỀN BẮC, 1995-2009



DIỄN BIẾN DỊCH TẢ THEO NGÀY KHỞI PHÁT TỪ 2007 - 2010



QUÁ TRÌNH DỊCH

1. Nguồn truyền nhiễm

- Là người bệnh và người mang khuẩn.
- Thể điển hình:
  - Ủ bệnh: 2-5 ngày; không lây
  - Phát bệnh: rầm rộ, lây mạnh
  - Lui bệnh: tiếp tục đào thải VK trong thời gian ngắn

QUÁ TRÌNH DỊCH

1. Nguồn truyền nhiễm (tiếp)

- Thể nhiễm khuẩn không triệu chứng: Trong một vụ dịch thể NK không TC thường gặp nhiều hơn thể NK có TC (đặc biệt với chủng Eltor).
  - V. cholerae eltor có tỷ lệ 1 bệnh nhân/30-100 người mang vi khuẩn.
  - V. cholerae classica: 1 bệnh nhân/2-4 người mang vi khuẩn

QUÁ TRÌNH DỊCH

1. Nguồn truyền nhiễm (tiếp):

- Thể nhẹ:
  - Ở trẻ em
  - Có ỉa chảy vài lần, thường không nôn, không đau bụng, không có dấu hiệu mất nước.
  - Rất quan trọng về mặt dịch tễ vì dễ bị bỏ qua
  - Chẩn đoán phải dựa vào cấy phân.

QUÁ TRÌNH DỊCH

1. Nguồn truyền nhiễm (tiếp)

- Thể tả khô:
  - Gặp ở người già hoặc những cơ thể suy kiệt
  - Bệnh nhân chết nhanh do tình trạng choáng trước khi xuất hiện ỉa lỏng và nôn.
  - Liệt ruột, trong lòng ruột chứa đầy dịch

QUÁ TRÌNH DỊCH

1. Nguồn truyền nhiễm (tiếp)

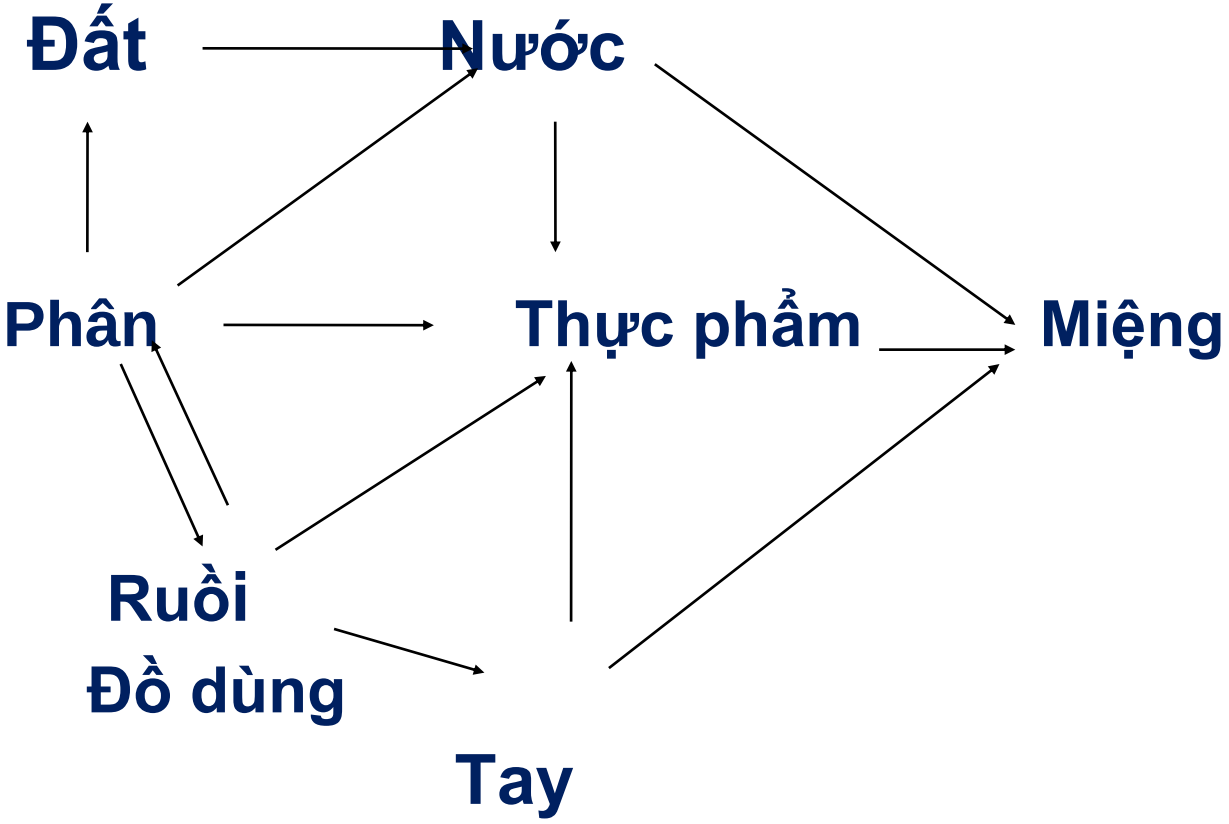
- Thể xuất huyết:
  - Lúc đầu là triệu chứng tả, sau có rối loạn đông máu gây xuất huyết dưới da, niêm mạc, phủ tạng.
  - Khi xuất huyết tiêu hoá, bệnh nhân ỉa ra nước phân và máu giống nước rửa thịt.
- Bệnh nhân có thể đào thải 107-108 VK/g phân.

QUÁ TRÌNH DỊCH

2. Đường truyền nhiễm

- **Đường tiêu hóa**
- Cơ chế truyền nhiễm: phân-miệng
- Yếu tố truyền nhiễm: nguồn nước, thực phẩm, rau quả... đặc biệt là một số hải sản như sò, ốc, hến được bắt từ những nơi ô nhiễm hoặc tay bẩn, dụng cụ ăn uống bị ô nhiễm, qua ruồi, nhặng, chuột, dán... làm lây lan mầm bệnh.

QUÁ TRÌNH DỊCH



QUÁ TRÌNH DỊCH

3. Khối cảm nhiễm

- Tất cả mọi người đều cảm nhiễm
- Khoảng 100 triệu VK vào đường tiêu hóa mới gây ra bệnh tả ở người lớn có sức khỏe bình thường
- Liều này thì thấp hơn đối với những người có axit dạ dày bị thấp

QUÁ TRÌNH DỊCH

3. Khối cảm nhiễm

- Trẻ em cũng nhạy cảm hơn, đối với trẻ 2 đến 4 tuổi có tỉ lệ mắc bệnh cao nhất
- Tính nhạy cảm phụ thuộc vào nhóm máu: O đến B -> A -> AB
- Những người có hệ miễn dịch bị suy giảm, như người mắc HIV/AIDS hay trẻ bị suy dinh dưỡng cũng là những đối tượng dễ bị nhiễm

BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

1. Các BP đối với nguồn truyền nhiễm

- Chẩn đoán:
- Điều trị:
- Cách ly
- Khử trùng
- Khai báo
- Quản lý, giám sát

BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

2. Các BP đối với đường TN

- Xử lý phân:
  - Giải quyết phân người đảm bảo vệ sinh, giữ gìn nhà xí không có ruồi.
  - Phân phải được chôn xa và phía dưới dòng nước chảy của nguồn nước dùng cho sinh hoạt.
  - Không dùng phân tươi bón ruộng
  - Loại bỏ hố xí thùng và hố xí một ngăn.

BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

2. Các BP đối với đường TN (tiếp)

- Cung cấp nước sạch:
  - Thành phố: cung cấp đủ nhu cầu nước, bảo đảm lượng Clo thừa đạt tiêu chuẩn quy định ở cuối đường ống.
  - Đối với nông thôn dùng giếng phải tôn trọng triệt để quy trình xây dựng, bảo vệ và sử dụng giếng.

BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

2. Các BP đối với đường TN (tiếp)

- Cung cấp nước sạch:
  - Không dùng nước bề mặt như nước sông, ao, hồ để ăn uống và sinh hoạt. Cần xây dựng các bể chứa nước mưa.
  - Bảo vệ, lắng lọc, khử trùng Clo đối với nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng.
  - Nước dùng cho cá nhân hoặc nhóm người đi du lịch phải được xử lý bằng Cloramin hoặc đun sôi.

BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

2. Các BP đối với đường TN

- Diệt ruồi:
  - Phòng chống ruồi bằng màn che phun hoá chất diệt ruồi, dùng bả ruồi, bẫy ruồi.
  - Phòng chống ruồi sinh sản bằng cách thường xuyên thu dọn, xử lý rác, xây dựng và duy trì nhà xí hợp vệ sinh.
- Vệ sinh ăn uống:
  - Từ khâu chọn thực phẩm đến chế biến bảo quản thực phẩm.
  - WHO đã xây dựng ”Mười nguyên tắc vàng để chế biến thực phẩm an toàn”

BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

2. Các BP đối với khối cảm nhiễm

- GDSK: ăn chín, uống sôi, rửa tay
- Vắc xin:
  - Tiêm: liều duy nhất, hiệu quả thấp <30%
  - Uống: 2 liều, hiệu quả 50-60%, ít tác dụng phụ, đã có mặt trên 60 quốc gia
  - Không có miễn dịch chéo giữa chủng O1 và O139.
- Hóa dược dự phòng

PHÒNG KHÁM
TIÊU CHẢY CẤP

VỰC
CH LY

KHU VỰC
CÁCH LY

2007

© Tristan Savatier - www.louptote.com

corbis

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình lý thuyết Dịch tễ học, Trường Đại học Y Hà Nội, Nhà xuất bản Y học 2013.
2. Cẩm nang phòng chống bệnh truyền nhiễm.Bộ Y tế 2009.
3. Bộ Y tế. Hướng dẫn phòng chống bệnh tả. Tài liệu hướng dẫn phòng chống bệnh tiêu chẩy cấp. Hà Nội, tháng 12/2002.